

急性非静脉曲张性上消化道出血 多学科防治专家共识(2019 版)

《中华消化外科杂志》编辑委员会 《中华消化杂志》编辑委员会

通信作者:董家鸿,清华大学附属北京清华长庚医院 清华大学临床医学院 清华大学精准医学研究院,北京 102218,Email:dongjiahong@mail.tsinghua.edu.cn;袁耀宗,上海交通大学医学院附属瑞金医院消化内科 200025,Email:yyz28@medmail.com.cn;楼文晖,复旦大学附属中山医院普通外科,上海 200032,Email:lou.wenhui@zs-hospital.sh.cn;杨尹默,北京大学第一医院普通外科 100034,Email:yangyinmo@263.net;谢渭芬,海军军医大学长征医院消化内科,上海 200003,Email:weifexie@medmail.com.cn

Expert consensus on multidisciplinary prevention and treatment of acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding (2019 edition)

Editorial Board of Chinese Journal of Digestive Surgery, Editorial Board of Chinese Journal of Digestion

Corresponding authors: Dong Jiahong, Beijing Tsinghua Changgung Hospital, School of Clinical Medicine, Institute for Precision Medicine, Tsinghua University, Beijing 102218, China, Email: dongjiahong@mail.tsinghua.edu.cn; Yuan Yaozong, Department of Digestion, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200025, China, Email: yyz28@medmail.com.cn; Lou Wenhui, Department of General Surgery, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China, Email: lou.wenhui@zs-hospital.sh.cn; Yang Yinmo, Department of General Surgery, Peking University First Hospital, Beijing 100034, China, Email: yangyinmo@263.net; Xie Weifen, Department of Digestion, Changzheng Hospital, Naval Medical University, Shanghai 200003, China, Email: weifexie@medmail.com.cn

【Key words】 Acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding; Prevention; Treatment; H₂ receptor antagonist; Proton pump inhibitors

【关键词】 急性非静脉曲张性上消化道出血; 预防; 治疗; H₂受体阻滞剂; 质子泵抑制剂

DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-9752.2019.12.002

急性非静脉曲张性上消化道出血(acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding, ANVUGIB)是临床最常见的危重急症之一。ANVUGIB 占上消化道出血的 80%~90%,以消化性溃疡、急慢性胃黏膜损伤和上消化道肿瘤等最常见。近年来,随着以阿司匹林为代表的非甾体抗炎药物(nonsteroidal antiinflammatory drug, NSAID)和抗血小板聚集药物应用的增加,药物导致的 ANVUGIB 日益受到重视。目前,国内外虽已发表多部 ANVUGIB 相关指南或共

识,但仍缺乏 ANVUGIB 预防及多学科综合诊断与治疗的相关内容。本共识由消化内科、普通外科、重症医学和介入科等多学科专家共同参与制订,结合国内外文献,以循证医学为基础,以问题为导向,结合临床经验,旨在为 ANVUGIB 的预防和多学科综合诊断与治疗提供指导。

本共识针对 ANVUGIB 临床预防与治疗的若干热点问题进行了评述,并依据美国内科医师协会临床指南委员会发布的证据分级评估系统(grading of recommendations assessment, development and evaluation, GRADE)提出指导性建议^[1]。

1 ANVUGIB 高危患者的药物预防

目前针对不同病因所致 ANVUGIB 高危患者的定义尚无一致标准。合并肝病、肾功能不全、败血症及各种危重症人群的消化道出血风险显著升高;长期使用阿司匹林等 NSAID 和糖皮质激素的人群 ANVUGIB 风险增加 38%~59%^[2]。

1.1 重症监护室(intensive care unit, ICU)危重症患者上消化道出血的预防

ICU 危重症患者在发病后 24 h 内即可合并应激相关的胃肠道黏膜损伤,发病后 1~3 d 行胃镜检查可发现 75%~100%的危重症患者合并胃黏膜损伤,其中应激性溃疡并发出血发生率为 8%(1%~17%),并发穿孔发生率约为 1%。一旦发生出血、穿孔,病死率可达 50%~80%,是 ICU 患者的常见死亡原因。预防 ICU 危重症患者上消化道出血常用药物主要为 H₂受体阻滞剂(H₂ receptor antagonist, H₂RA)和质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)。

一项 Meta 分析显示:与安慰剂或空白对照相

比,预防性应用 H2RA、抗酸药和黏膜保护剂可分别使 ICU 患者上消化道出血风险下降 11%、9% 和 5%^[3]。国内外多数研究显示:H2RA 和 PPI 均可预防 ICU 患者消化道出血,PPI 疗效优于 H2RA^[3-6]。ICU 患者早期肠内营养对应激性溃疡有一定预防作用,对于联合肠内营养的 ICU 患者,H2RA 和 PPI 也可降低消化道出血的风险。

我国一项多中心研究纳入预期机械通气超过 48 h 的 274 例 ICU 患者,比较艾司奥美拉唑(40 mg, 2 次/d)和西米替丁(50 mg/h)预防消化道出血的作用,其结果显示:2 种药物预防消化道出血的效果差异无统计学意义^[7]。一项纳入 35 312 例 ICU 急重症患者的回顾性研究报道:对于机械通气时间超过 24 h 的患者需预防性应用抑酸药物,与 H2RA 组比较,PPI 组患者合并消化道出血、新发肺炎和难辨梭菌感染的风险分别为前者的 2.24、1.20 和 1.29 倍^[8]。近期一项研究比较 PPI 与 H2RA 对于 ICU 患者应激性溃疡的预防作用,其研究结果显示:PPI 组患者消化道大出血风险是 H2RA 组患者的 2 倍,进一步敏感性分析未发现 PPI 在预防消化道大出血方面优于 H2RA^[9]。目前新型 H2RA(如罗沙替丁等)抑酸效果和 PPI 相当,显著强于既往 H2RA 类药物^[10]。

建议 1:ICU 危重症患者应激性胃肠道黏膜损伤和出血风险显著增加,预防应用 H2RA 或 PPI 可显著降低其出血风险。(证据等级:高;推荐级别:强烈推荐)

1.2 合并幽门螺杆菌感染患者消化性溃疡出血的预防

消化性溃疡是上消化道出血的常见原因之一,根除幽门螺杆菌是幽门螺杆菌阳性消化性溃疡患者的基础治疗,是促进溃疡愈合,预防复发和溃疡出血的有效措施。一项 Meta 分析显示:根除幽门螺杆菌对于消化性溃疡再出血的预防作用优于单纯的短期或长期抑酸治疗^[11]。幽门螺杆菌阳性消化性溃疡出血患者保守治疗后若未行幽门螺杆菌根除治疗,12 个月内再次出血率高达 26%,而幽门螺杆菌根除成功后的溃疡出血患者经 11~53 个月随访,再出血率仅为 1.3%^[12]。

一项队列研究显示:幽门螺杆菌阳性的消化性溃疡患者宜在诊断 7 d 内行幽门螺杆菌根除治疗,延迟治疗可使溃疡复发和远期胃癌的风险增加^[13]。幽门螺杆菌复查应在根除治疗 4 周且 PPI 至少停药 2 周后进行,可减少假阴性结果。若复查结果为阴性且患者不需要应用 NSAID,可停用抑酸治疗。如

经 2 次标准方案治疗后幽门螺杆菌根除失败,应评估根除治疗风险和获益,选择 H2RA 或 PPI 长期抑酸治疗。

建议 2:消化性溃疡的规范治疗是预防其继发出血的基础,所有幽门螺杆菌阳性的消化性溃疡患者应行幽门螺杆菌根除治疗。(证据等级:高;推荐级别:强烈推荐)

1.3 长期服用低剂量阿司匹林和抗血小板药物相关上消化道出血的预防

长期服用低剂量阿司匹林可致消化道损伤,继发黏膜糜烂、溃疡和出血等并发症。有研究结果显示:长期服用低剂量阿司匹林继发上消化道出血的年发生率为 0.6%,出血风险升高 1.6 倍^[14]。阿司匹林相关性溃疡出血的危险因素包括溃疡出血史、已有消化性溃疡、年龄>70 岁、幽门螺杆菌感染、联合应用其他药物如抗血小板药物和抗凝药等^[15]。

抗血小板药物 P2Y₁₂ 受体拮抗剂(氯吡格雷等)不同于阿司匹林,其不直接损伤消化道黏膜,但可阻碍血管新生并影响溃疡愈合。P2Y₁₂ 受体拮抗剂可加重已有的胃肠道黏膜损伤,与阿司匹林联用时效果更为严重。与氯吡格雷比较,新型 P2Y₁₂ 受体拮抗剂疗效虽优,但出血发生率较高,其中普拉格雷可致胃肠道出血发生率升高 46%,替格瑞洛可升高 32%^[15]。

预防性应用抑酸药前应审慎评估抗血小板治疗的适应证。一项 Meta 分析提示:长期服用阿司匹林作为一级预防仅能轻度降低主要心血管事件的风险,并不能减少心肌梗死和脑卒中的发生,降低其病死率,但可致消化道出血风险升高 29%^[16]。因此,消化道出血风险可能高于作为一级预防措施潜在获益。针对长期服用低剂量阿司匹林作为心血管事件二级预防的患者,若合并消化道并发症高危因素应联合应用抑酸药物。一项为期 12 个月的随机对照试验发现:H2RA 和 PPI 可有效预防消化道出血高危患者因长期服用低剂量阿司匹林所致的再出血,两者疗效差异无统计学意义^[17]。一项 Meta 分析显示:长期服用低剂量阿司匹林患者应用 H2RA 或 PPI 预防消化性溃疡和出血,可使风险分别下降 73% 和 84%,PPI 效果可能优于 H2RA^[18]。

应用 H2RA 或 PPI 可有效预防阿司匹林和氯吡格雷双联抗血小板治疗所致消化道损伤,PPI 可使双联抗血小板治疗患者上消化道出血风险减少 87%。PPI 作为预防抗血小板药物相关消化道损伤的首选药物,优于米索前列醇等黏膜保护剂和 H2RA,亦有

Meta 分析显示:H2RA 和 PPI 预防双联抗血小板治疗患者上消化道出血的效果差异无统计学意义^[19]。

建议 3:长期低剂量服用阿司匹林的消化道出血高危患者、行阿司匹林和 P2Y₁₂ 受体拮抗剂双联抗血小板治疗的患者应予 H2RA 或 PPI 预防上消化道出血。(证据等级:高;推荐级别:强烈推荐)

1.4 NSAID 相关上消化道出血的预防

除阿司匹林外,NSAID 还包括对乙酰氨基酚、吲哚美辛、萘普生、萘普酮、双氯芬酸、布洛芬、塞来昔布、尼美舒利和罗非昔布等。根据长期服用 NSAID 所致胃肠道并发症的风险,可将患者分为高危、中危和低危。对于无法停用 NSAID 患者,目前指南或共识性文献多提倡应用环氧化酶 2(cyclooxygenase 2, COX2)抑制剂联合 PPI 预防消化性溃疡及其出血并发症。

将 NSAID 更换为 COX2 抑制剂并联合 PPI 治疗,有助于预防再出血,随访 12 个月内再出血风险明显低于单纯 COX2 抑制剂治疗。对于长期服用 NSAID 的上消化道出血中高危患者,PPI 改善 NSAID 相关溃疡及其并发症的治疗效果优于 H2RA。一项纳入 353 例 NSAID 相关性溃疡患者的随机对照研究显示:雷尼替丁(150 mg,2 次/d)、兰索拉唑(15 mg,1 次/d)和兰索拉唑(30 mg,1 次/d)治疗 8 周后溃疡愈合率分别为 53%、69%和 73%^[20]。针对长期服用 NSAID 上消化道出血中低危患者的预防性治疗,尚缺乏大样本研究比较 PPI 和 H2RA 的疗效。

建议 4:NSAID 相关上消化道出血的预防性治疗应依据其危险分层个体化选择,COX2 抑制剂联合 PPI 使用效果较好。(证据等级:高;推荐级别:强烈推荐)

1.5 长期应用 NSAID 且幽门螺杆菌阳性患者上消化道出血的治疗

NSAID 和幽门螺杆菌感染是消化性溃疡及其并发症的独立危险因素,长期服用阿司匹林等 NSAID 可增加幽门螺杆菌感染患者发生消化性溃疡和出血的风险,根除幽门螺杆菌可降低其风险。有 Meta 分析显示:幽门螺杆菌感染、应用 NSAID 以及两者同时存在时消化道出血的风险分别升高 1.79 倍、4.85 倍和 6.13 倍^[21]。因此,对于拟长期服用 NSAID 的幽门螺杆菌阳性患者,先行根除幽门螺杆菌治疗可显著降低后续消化性溃疡和出血并发症的风险。一项 Meta 分析显示:幽门螺杆菌根除作为长期服用 NSAID 患者消化道出血的一级预

防措施显著优于安慰剂^[22]。

对于长期服用阿司匹林等 NSAID 的幽门螺杆菌阳性患者,单纯幽门螺杆菌根除治疗而不予 PPI 维持治疗不足以有效预防溃疡出血,单纯幽门螺杆菌根除也不能促进溃疡愈合。因此,不推荐幽门螺杆菌阳性且长期服用 NSAID 患者仅行幽门螺杆菌根除而不予 PPI 维持治疗。日本胃肠病学会 2015 年《消化性溃疡临床指南》提出:对于已使用 NSAID 患者,单独幽门螺杆菌根除治疗预防溃疡发生不如 PPI 维持治疗,故不推荐幽门螺杆菌阳性且长期服用 NSAID 患者单独行幽门螺杆菌根除治疗而不行 PPI 维持治疗^[23]。

建议 5:长期应用阿司匹林等 NSAID 的幽门螺杆菌阳性患者应予幽门螺杆菌根除治疗,并根据消化道并发症危险分层同时行 PPI 或 H2RA 预防治疗。(证据等级:高;推荐级别:强烈推荐)

1.6 上消化道血管病变相关出血及再出血患者的预防性治疗

血管病变导致上消化道出血少见,包括杜氏病、胃窦血管扩张和血管发育异常等,内镜治疗是主要治疗手段,抑酸药应作为常规药物用于再出血的预防,尚无证据明确其在该类上消化道出血及再出血中的治疗和预防作用^[24]。

建议 6:内镜是治疗上消化道血管病变相关出血及预防再出血的主要手段,抑酸药的预防和治疗作用尚不明确。(证据等级:低;推荐级别:一般性推荐)

1.7 特发性消化性溃疡出血和再出血的预防

特发性消化性溃疡病因不明,与阿司匹林等 NSAID 和幽门螺杆菌感染无关,且无其他明确致病因素,如肿瘤和卓-艾综合征等。一项观察性研究显示:特发性消化性溃疡患者在随访 7 年内再出血率高达 42%,目前尚无针对该类患者联合抑酸治疗的随机对照研究^[25]。建议该类患者长期应用 PPI 抑酸治疗。

建议 7:特发性消化性溃疡患者应长期使用 H2RA 或 PPI 预防出血和再出血。(证据等级:低;推荐级别:一般性推荐)

1.8 上消化道肿瘤所致出血患者的预防

由于肿瘤组织缺血性坏死、表面形成溃疡或肿瘤侵蚀血管等可致上消化道出血。恶性肿瘤患者一旦合并消化道出血,再出血风险大,往往提示预后不良。上消化道肿瘤合并出血患者的预防性保守治疗效果较差,加强对终末期患者上消化道出血的监控,重视危险因素,早期预防和治疗,有助于改善不可切

除患者的生命质量,相关危险因素包括幽门螺杆菌感染、应用 NSAID、应激状态和长期心肺疾病等。对于无法手术切除的上消化道肿瘤,积极监测幽门螺杆菌感染并及时根除治疗,可降低出血导致的病死率。对于需长期应用 NASID 类药物的患者,应联合应用 H2RA 或 PPI。对于不能手术切除的胃癌患者,PPI 治疗并不能降低肿瘤出血率,也不能延长生存期^[26]。因此,对于上消化道肿瘤,肿瘤的根治或姑息性切除是预防出血的最佳措施;对于不可切除的患者,根据肿瘤部位、活组织检查和基因检测结果选择化学治疗或靶向治疗以使其缩小或降期,亦是预防肿瘤合并出血的有效手段。

建议 8:对于不可切除的上消化道肿瘤患者,应祛除并发肿瘤出血的危险因素;PPI 治疗不能降低不可切除胃癌患者的出血率。(证据等级:中;推荐级别:一般性推荐)

1.9 上消化道手术术后吻合口出血的预防与治疗

上消化道手术常见的吻合口包括胃肠、胰肠和胆肠吻合口等,吻合口出血是外科术后严重并发症之一,发现不及时或处理不当可危及生命。各种吻合口出血的发生率国内外文献报道不一致。术后 24 h 内发生的出血称为早期出血,术后 24 h 后发生的出血称为迟发出血^[27]。引起出血的因素主要有:①采用直线切割闭合器重建胃肠吻合口时,由于吻合钉脱落、钉夹高度选择不当等原因,钉仓间可发生活动性小动脉出血。②使用管型吻合器行食管空肠端侧吻合,闭合器闭合不良引起食管空肠吻合出血。③胰腺残端被消化液腐蚀出现胰肠或胰胃吻合出血。④胆肠吻合口不愈合引起胆肠吻合口出血。⑤凝血功能障碍和抗凝药物的使用导致术后吻合口出血等。目前尚无常规应用制酸剂预防胃肠道手术后吻合口出血的证据。

建议 9:完善围术期处理,及时纠正凝血功能异常,停用抗凝药物,术中精细操作,彻底有效地止血是有效预防术后早期吻合口出血的重要措施。(证据等级:低;推荐级别:一般性推荐)

2 ANVUGIB 患者的多学科管理

2.1 疑似消化道出血患者的临床决策

针对显性消化道出血患者,首先需评估循环状态并予液体复苏治疗^[28]。风险评估有助于判断 ANVUGIB 患者再出血风险,目前临床常用的评分系统包括 Blatchford 评分和 Rockall 评分,Blatchford 评分系统用于在内镜检查前预判断哪些患者需要接受

输血、内镜检查或手术等后续干预措施,其取值范围为 0~23 分^[29]。Rockall 评分系统用于评估上消化道出血患者病死率,该系统依据患者年龄、休克状况、伴发疾病、内镜诊断和内镜下出血征象 5 项指标,将患者分为高危、中危或低危人群,其取值范围为 0~11 分。2 种评分系统均无法准确识别出血患者是否需要干预(输血、内镜治疗和手术治疗),但 Blatchford 评分为 0 分的患者需要干预的比例不足 1%,这部分患者占以“上消化道出血”为主诉就诊患者的 5%~20%。

建议 10:所有疑似消化道出血患者应及时完善血流动力学评估,并根据风险分层进行临床决策。(证据等级:低;推荐级别:一般性推荐)

2.2 上消化道再出血高风险患者的治疗

国内有研究显示 Forrest 分级、血红蛋白、休克、溃疡大小是影响消化性溃疡出血患者发生早期再出血的危险因素,内镜下止血治疗可降低再出血风险^[30]。对于血流动力学稳定、无严重合并症、再出血风险低的 ANVUGIB 患者,症状出现 6 h 内行内镜检查并不影响其临床转归,但有助于及早开始病因治疗,缩短住院时间,减少医疗支出。再出血高危(Blatchford 评分 ≥ 12 分)ANVUGIB 患者,症状出现 12 h 内完成内镜检查可有效降低病死率^[31]。

抑酸药在提高胃内 pH 值 >6 的同时可抑制胃蛋白酶活化,促进血小板聚集和纤维蛋白凝块形成,避免血凝块过早溶解,有利于止血和预防再出血。一项 Meta 分析显示:虽然内镜操作前使用 PPI 不会显著降低上消化道出血患者再出血、手术治疗率及其死亡风险,但可降低内镜止血的需求和操作难度^[32]。针对无法进行内镜治疗的患者,PPI 可降低再出血和手术治疗的危险。

常用的内镜治疗方法包括药物局部注射、热凝和机械止血 3 种。针对活动性出血病灶,可选择局部肾上腺素注射治疗联合热凝止血、机械止血或硬化剂注射等方法。虽然局部药物注射简便易行,但止血效果欠佳,不应单独作为内镜下止血治疗方案。针对未出血的裸露血管,推荐热凝止血、机械止血或硬化剂注射作为内镜治疗主要手段,或联合局部肾上腺素注射治疗。针对常规方法难以控制的活动性出血,建议尝试局部止血药喷洒或止血夹止血作为补救性内镜治疗,但目前尚缺乏高质量研究证据支持。

Forrest II b 级病变若无内镜下治疗,再出血率高达 22%。然而 Meta 分析显示:Forrest II b 级病变内镜治疗相较保守治疗在亚洲地区人群中无明显获

益,可考虑冲洗剥离血凝块后再次评估 Forrest 分级,活动性出血应行内镜下止血^[32]。

溃疡出血患者在内镜止血后继续使用大剂量 PPI 可明显降低再出血风险。一项 Meta 分析显示:Forrest I a、I b、II a、II b 级患者在内镜止血后继续使用大剂量 PPI (80 mg 静脉滴注+8 mg/h 静脉维持)治疗 72 h 可使再出血率和病死率分别下降 60% 和 59%^[33]。另外一项纳入 Forrest I a、I b、II a 级患者的前瞻性随机对照研究指出:在内镜下局部肾上腺素注射成功止血后大剂量奥美拉唑 (40 mg, 1 次/6 h) 预防再出血的风险明显低于奥美拉唑 (40 mg, 1 次/12 h) 或西咪替丁 (400 mg, 1 次/12 h)^[34]。近来一项大规模随机对照研究显示:在内镜止血成功后若无大剂量 PPI 序贯治疗,Forrest I a、II b、II a 级病变再出血的风险分别为 22.5%、17.6%、11.3%,而活动性渗血病变 (Forrest I b 级) 再出血风险仅为 4.9%,若联合大剂量 PPI 序贯治疗,Forrest I a、II b、II a 级病变再出血的风险显著下降,而 I b 级病变再出血风险无明显改善^[35]。

建议 11:上消化道出血患者初诊 24 h 内应完成内镜检查,内镜下止血适于 Forrest I a 级喷射样出血、I b 级活动性渗血和 II a 级裸露血管患者。(证据等级:中;推荐级别:一般性推荐)

建议 12:上消化道再出血风险高的患者应尽早使用大剂量 PPI (80 mg 静脉滴注+8 mg/h 静脉维持)持续 72 h,并根据内镜下分型和止血结果及时调整。(证据等级:高;推荐级别:强烈推荐)

2.3 内镜止血失败 ANVUGIB 患者的治疗

内镜止血失败患者的挽救性治疗方式可选择经导管动脉栓塞 (transcatheter arterial embolization, TAE) 或外科手术。对内镜止血失败或外科手术风险较大的患者,DSA 有助于明确出血部位与病因,并可行 TAE 治疗。TAE 属微创操作,目前国内开展已较为普遍,对于介入科能开展 TAE 的医院可将 TAE 作为内镜止血失败后的首选措施,但术后再出血率高达 35.5%^[36]。对存在复杂合并症的高龄患者或凝血功能障碍等不适合外科手术的高危患者宜首先考虑行 TAE。对出血部位比较明确的出血,可行选择性栓塞;对于无法明确出血部位的患者,可根据内镜下止血夹位置行经验性栓塞。

内镜止血治疗后的高危再出血患者早期行 TAE 可降低其再出血风险。一项纳入 115 例内镜止血治疗后高危再出血患者 (Forrest I a、I b 级或 Rockall 评分 ≥ 5 分) 的随机对照研究显示:TAE 组再出血率

数值比标准治疗组略下降 (4.1% 比 14.3%),但差异无统计学意义^[37]。近期一项纳入 241 例内镜治疗后高危再出血患者 (内镜下喷射性出血、溃疡直径 ≥ 20 mm、Hb < 9 g/dL 或休克) 的随机对照研究显示:相比于常规治疗 (大剂量静脉 PPI 输注和幽门螺杆菌根除),内镜止血后 12 h 内联合 TAE 组患者再出血率 (6.2% 比 11.4%) 和病死率 (0 比 4.1%) 均略下降,但差异无统计学意义,但对溃疡直径 ≥ 15 mm 的高危患者,早期 TAE 可显著降低溃疡再出血风险 (4.5% 比 23.1%)^[38]。

对于病因明确的 ANVUGIB 患者,经药物、内镜和 (或) 放射介入治疗等多学科治疗,出血仍然不能控制,病情紧急时应积极采用手术治疗,手术治疗后再出血率为 17.7%^[38]。其中,对于上消化道肿瘤并发出血者应考虑根治性切除,不能切除的肿瘤非手术治疗失败时,也应争取姑息性手术以控制出血。对于病因不明的 ANVUGIB,经非手术治疗仍不能止血、病情凶险者,则应手术探查,术中可结合内镜检查,明确出血部位和病因后再进行针对性治疗。

目前尚无随机对照临床研究比较 TAE 和手术在内镜治疗无效的顽固性出血患者中的安全性和有效性。一项基于回顾性研究的 Meta 分析共纳入 427 例行 TAE 和 650 例行手术治疗的 ANVUGIB 患者,其研究结果显示:TAE 术后病死率略低于外科手术 (21.8% 比 25.4%),术后并发症率更低 (31.1% 比 49.7%),但再出血率明显高于外科手术 (35.5% 比 17.7%)^[38]。

建议 13:对内镜止血失败的 ANVUGIB 患者,应尽快行 TAE 或手术治疗;对存在复杂合并症的高龄患者或凝血功能障碍等不适合外科手术的高危患者宜首先考虑行 TAE。(证据等级:中;推荐级别:强烈推荐)

ANVUGIB 是临床常见的消化系统急症之一,有活动性出血的 ANVUGIB 常伴血流动力学障碍,严重者可危及生命。本共识对既往 ANVUGIB 防治措施进行系统总结,有较高级别的证据支持,但部分内容仍缺乏高质量循证医学证据。鉴于 ANVUGIB 病因复杂多样,临床实践中患者个体差异明显,需结合患者、科室和医院的客观实际情况,遵循个体化原则。另外,ANVUGIB 的防治涉及消化内科、普通外科、药学、放射介入科、ICU 和血液内科等多个学科,提倡建立 ANVUGIB 多学科防治团队,对其规范化预防及改善治疗效果具有重要意义,亦有助于进一步积累经验和证据,在循证医学指导下积极开展多中心临床研究,促进现有共识的进一步完善。

《急性非静脉曲张性上消化道出血多学科防治专家共识》编审委员会成员名单

组长:董家鸿 袁耀宗

成员(按姓氏汉语拼音排序):

白雪莉 曹 晖 陈 敏 陈其奎 陈亚进 董家鸿
樊海宁 冯 纓 郭亚民 韩国宏 郝建宇 胡三元
霍 枫 姜卫东 简志祥 蓝 宇 李宏宇 李景南
梁廷波 刘连新 楼文晖 卢绮萍 沈 锋 施 健
孙 艳 孙忠实 汪芳裕 王学红 谢渭芬 许 乐
阎鹏光 杨连粤 杨尹默 袁耀宗 曾 勇 张雷达
张太平 张学文 张跃伟 张振宇 周丽雅

执笔:姜卫东 施 健 阎鹏光

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Qaseem A, Snow V, Owens DK, et al. The development of clinical practice guidelines and guidance statements of the American College of Physicians: summary of methods[J]. Ann Intern Med, 2010, 153 (3): 194-199. DOI: 10.7326/0003-4819-153-3-201008030-00010.
- [2] Crooks CJ, West J, Card TR. Comorbidities affect risk of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding[J]. Gastroenterology, 2013, 144(7): 1384-1393. DOI: 10.1053/j.gastro.2013.02.040.
- [3] Toews I, George AT, Peter JV, et al. Interventions for preventing upper gastrointestinal bleeding in people admitted to intensive care units[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2018, 6: CD008687. DOI: 10.1002/14651858.CD008687.pub2.
- [4] Alhazzani W, Alshamsi F, Belley-Cote E, et al. Efficacy and safety of stress ulcer prophylaxis in critically ill patients: a network meta-analysis of randomized trials[J]. Intensive Care Med, 2018, 44(1): 1-11. DOI: 10.1007/s00134-017-5005-8.
- [5] Liu BL, Li B, Zhang X, et al. A randomized controlled study comparing omeprazole and cimetidine for the prophylaxis of stress-related upper gastrointestinal bleeding in patients with intracerebral hemorrhage[J]. J Neurosurg, 2013, 118 (1): 115-120. DOI: 10.3171/2012.9.JNS12170.
- [6] Conrad SA, Gabrielli A, Margolis B, et al. Randomized, double-blind comparison of immediate-release omeprazole oral suspension versus intravenous cimetidine for the prevention of upper gastrointestinal bleeding in critically ill patients[J]. Crit Care Med, 2005, 33(4): 760-765. DOI: 10.1097/01.ccm.0000157751.92249.32.
- [7] Lou W, Xia Y, Xiang P, et al. Prevention of upper gastrointestinal bleeding in critically ill Chinese patients: a randomized, double-blind study evaluating esomeprazole and cimetidine[J]. Curr Med Res Opin, 2018, 34 (8): 1449-1455. DOI: 10.1080/03007995.2018.1464132.
- [8] MacLaren R, Reynolds PM, Allen RR. Histamine-2 receptor antagonists vs proton pump inhibitors on gastrointestinal tract hemorrhage and infectious complications in the intensive care unit[J]. JAMA Intern Med, 2014, 174(4): 564-574. DOI: 10.1001/jamainternmed.2013.14673.
- [9] Lilly CM, Aljawadi M, Badawi O, et al. Comparative effectiveness of proton pump inhibitors vs histamine type 2 receptor blockers for preventing clinically important gastrointestinal bleeding during intensive care: a population-based study[J]. Chest, 2018, 154 (3): 557-566. DOI: 10.1016/j.chest.2018.05.015.
- [10] Inaeda H, Hosoe N, Suzuki H, et al. Effect of lansoprazole versus roxatidine on prevention of bleeding and promotion of ulcer healing after endoscopic submucosal dissection for superficial gastric neoplasia[J]. J Gastroenterol, 2011, 46 (11): 1267-1272. DOI: 10.1007/s00535-011-0447-1.
- [11] Gisbert JP, Khorrami S, Carballo F, et al. H. pylori eradication therapy vs. antisecretory non-eradication therapy (with or without long-term maintenance antisecretory therapy) for the prevention of recurrent bleeding from peptic ulcer[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2004, (2): CD004062. DOI: 10.1002/14651858.CD004062.pub2.
- [12] Gisbert JP, Khorrami S, Carballo F, et al. Meta-analysis: helicobacter pylori eradication therapy vs. antisecretory non-eradication therapy for the prevention of recurrent bleeding from peptic ulcer[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2004, 19 (6): 617-629. DOI: 10.1111/j.1365-2036.2004.01898.x.
- [13] Sverdrén E, Brusselaers N, Wahlin K, et al. Time latencies of helicobacter pylori eradication after peptic ulcer and risk of recurrent ulcer, ulcer adverse events, and gastric cancer: a population-based cohort study[J]. Gastrointest Endosc, 2018, 88 (2): 242-250. e1. DOI: 10.1016/j.gie.2017.11.035.
- [14] Hsu PI, Tsai TJ. Epidemiology of upper gastrointestinal damage associated with low-dose aspirin[J]. Curr Pharm Des, 2015, 21 (35): 5049-5055. DOI: 10.2174/1381612821666150915104800.
- [15] Di Minno A, Spadarella G, Prisco D, et al. Antithrombotic drugs, patient characteristics, and gastrointestinal bleeding: clinical translation and areas of research[J]. Blood Rev, 2015, 29(5): 335-343. DOI: 10.1016/j.blre.2015.03.004.
- [16] Berger JS, Lala A, Krantz MJ, et al. Aspirin for the prevention of cardiovascular events in patients without clinical cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized trials[J]. Am Heart J, 2011, 162(1): 115-124. e2. DOI: 10.1016/j.ahj.2011.04.006.
- [17] Chan FK, Kyaw M, Tanigawa T, et al. Similar efficacy of proton-pump inhibitors vs H2-receptor antagonists in reducing risk of upper gastrointestinal bleeding or ulcers in high-risk users of low-dose aspirin[J]. Gastroenterology, 2017, 152 (1): 105-110. e1. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.09.006.
- [18] Mo C, Sun G, Lu ML, et al. Proton pump inhibitors in prevention of low-dose aspirin-associated upper gastrointestinal injuries[J]. World J Gastroenterol, 2015, 21 (17): 5382-5392. DOI: 10.3748/wjg.v21.i17.5382.
- [19] Yi ZM, Qiu TT, Zhang Y, et al. Comparison of prophylactic effect of UGIB and effects on platelet function between PPIs and H(2) RAs combined with DAPT: systematic review and meta-analysis[J]. Ther Clin Risk Manag, 2017, 13: 367-377. DOI: 10.2147/TCRM.S127292.
- [20] Agrawal NM, Campbell DR, Safdi MA, et al. Superiority of lansoprazole vs ranitidine in healing nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated gastric ulcers: results of a double-blind, randomized, multicenter study. NSAID-Associated Gastric Ulcer Study Group[J]. Arch Intern Med, 2000, 160(10): 1455-1461. DOI: 10.1001/archinte.160.10.1455.
- [21] Huang JQ, Sridhar S, Hunt RH. Role of helicobacter pylori infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs in peptic-ulcer disease: a meta-analysis[J]. Lancet, 2002, 359(9300): 14-22. DOI: 10.1016/S0140-6736(02)07273-2.
- [22] Vergara M, Catalán M, Gisbert JP, et al. Meta-analysis: role of helicobacter pylori eradication in the prevention of peptic ulcer in NSAID users[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2005, 21 (12): 1411-1418. DOI: 10.1111/j.1365-2036.2005.02444.x.
- [23] Satoh K, Yoshino J, Akamatsu T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for peptic ulcer disease 2015[J]. J Gastroenterol, 2016, 51(3): 177-194. DOI: 10.1007/s00535-016-1166-4.
- [24] Ji JS, Kim HK, Kim SS, et al. Clinical outcome of endoscopic management of duodenal Dieulafoy's lesions: endoscopic band ligation versus endoscopic hemoclip placement[J]. Surg Endosc, 2016, 30(8): 3526-3531. DOI: 10.1007/s00464-015-4642-7.

- [25] Wong GL, Wong VW, Chan Y, et al. High incidence of mortality and recurrent bleeding in patients with helicobacter pylori-negative idiopathic bleeding ulcers [J]. *Gastroenterology*, 2009, 137 (2): 525-531. DOI:10.1053/j.gastro.2009.05.006.
- [26] Kim YI, Kim MJ, Park SR, et al. Effect of a proton pump inhibitor on tumor bleeding prevention in unresectable gastric cancer patients: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial [J]. *J Gastric Cancer*, 2017, 17(2): 120-131. DOI:10.5230/jgc.2017.17.e15.
- [27] Correa-Gallego C, Brennan MF, D'Angelica MI, et al. Contemporary experience with postpancreatectomy hemorrhage: results of 1,122 patients resected between 2006 and 2011 [J]. *J Am Coll Surg*, 2012, 215(5): 616-621. DOI:10.1016/j.jamcollsurg.2012.07.010.
- [28] 中国医师协会急诊医师分会. 急性上消化道出血急诊诊治流程专家共识 [J]. *中国急救医学*, 2015, 35(10): 865-873. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2015.10.001.
- [29] 《中华内科杂志》编辑部,《中华医学杂志》编辑部,《中华消化杂志》编辑部,等. 急性非静脉曲张性上消化道出血诊治指南 (2018 年, 杭州) [J]. *中华消化杂志*, 2019, 39(2): 80-87. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2019.02.002.
- [30] 张丽娜, 马治国, 杨少奇, 等. 消化性溃疡出血患者早期再出血的危险因素分析 [J]. *中华消化杂志*, 2018, 38(8): 543-547. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2018.08.008.
- [31] Lim LG, Ho KY, Chan YH, et al. Urgent endoscopy is associated with lower mortality in high-risk but not low-risk nonvariceal upper gastrointestinal bleeding [J]. *Endoscopy*, 2011, 43(4): 300-306. DOI:10.1055/s-0030-1256110.
- [32] Sreedharan A, Martin J, Leontiadis GI, et al. Proton pump inhibitor treatment initiated prior to endoscopic diagnosis in upper gastrointestinal bleeding [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2010, (7): CD005415. DOI:10.1002/14651858.CD005415.pub3.
- [33] Leontiadis GI, Sharma VK, Howden CW. Proton pump inhibitor therapy for peptic ulcer bleeding: Cochrane collaboration meta-analysis of randomized controlled trials [J]. *Mayo Clin Proc*, 2007, 82(3): 286-296. DOI:10.4065/82.3.286.
- [34] Lin HJ, Lo WC, Cheng YC, et al. Role of intravenous omeprazole in patients with high-risk peptic ulcer bleeding after successful endoscopic epinephrine injection: a prospective randomized comparative trial [J]. *Am J Gastroenterol*, 2006, 101(3): 500-505. DOI:10.1111/j.1572-0241.2006.00399.x.
- [35] Jensen DM, Eklund S, Persson T, et al. Reassessment of rebleeding risk of forrest IB (Oozing) peptic ulcer bleeding in a large international randomized trial [J]. *Am J Gastroenterol*, 2017, 112(3): 441-446. DOI:10.1038/ajg.2016.582.
- [36] Tarasconi A, Baiocchi GL, Pattonieri V, et al. Transcatheter arterial embolization versus surgery for refractory non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis [J]. *World J Emerg Surg*, 2019, 14:3. DOI:10.1186/s13017-019-0223-8.
- [37] Laursen SB, Hansen JM, Andersen PE, et al. Supplementary arterial embolization an option in high-risk ulcer bleeding—a randomized study [J]. *Scand J Gastroenterol*, 2014, 49(1): 75-83. DOI:10.3109/00365521.2013.854829.
- [38] Lau JYW, Pittayanon R, Wong KT, et al. Prophylactic angiographic embolisation after endoscopic control of bleeding to high-risk peptic ulcers: a randomised controlled trial [J]. *Gut*, 2019, 68(5): 796-803. DOI:10.1136/gutjnl-2018-316074.

(收稿日期: 2019-11-05)

本文引用格式

《中华消化外科杂志》编辑委员会,《中华消化杂志》编辑委员会. 急性非静脉曲张性上消化道出血多学科防治专家共识 (2019 版) [J]. *中华消化外科杂志*, 2019, 18(12): 1094-1100. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-9752.2019.12.002.

Editorial Board of Chinese Journal of Digestive Surgery, Editorial Board of Chinese Journal of Digestion. Expert consensus on multidisciplinary prevention and treatment of acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding (2019 edition) [J]. *Chin J Dig Surg*, 2019, 18(12): 1094-1100. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-9752.2019.12.002.

• 读者 • 作者 • 编者 •

本刊 2020 年各期重点选题

精心策划选题, 引领学术前沿一直是《中华消化外科杂志》秉承的办刊路线。专家办刊是杂志兴旺发达的不竭动力, 优质的稿源不仅是引领学术前沿的风向标, 更是提升期刊学术质量的重要基础。经本刊编辑委员会讨论确定了 2020 年各期重点选题。请各位作者根据每期重点选题提前 4~5 个月通过远程投稿系统投稿, 本刊将择优刊登。

电子邮箱: digisurg@zhxhwk.com

远程投稿: <http://cmaes.medline.org.cn>官方网站: <http://www.zhxhwk.com>

微信公众号: 中华消化外科杂志

第 1 期: 消化外科新进展

第 2 期: 肝癌综合治疗

第 3 期: 结直肠肿瘤的保功能手术

第 4 期: 胰腺良性疾病

第 5 期: 微创外科

第 6 期: 食管疾病与食管胃结合部腺癌

第 7 期: 疝与腹壁外科

第 8 期: 胆道良性疾病

第 9 期: 胃肿瘤手术的消化道重建

第 10 期: 外科感染与营养

第 11 期: 减重代谢外科

第 12 期: 肝胆胰恶性疾病围术期综合治疗